Клинические рекомендации

Аллергический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.1** — Аллергический ринит, вызванный пыльцой растений **J30.2** — Другие сезонные аллергические риниты **J30.3** — Другие аллергические риниты **J30.4** — Аллергический ринит неуточненный
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 11.07.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/261_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация 4

2.3 Жалобы и анамнез 4

2.4 Физикальное обследование 5

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Передняя риноскопия 5

3.3 Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки и околоносовых пазух 5

3.4 Кожные пробы 6

3.5 Специфические IgE в сыворотке крови 6

3.6 Общий IgE 6

3.7 Общий (клинический) анализ крови 6

3.8 Цитологическое исследование смывов из полости носа 6

3.9 Рентгенография околоносовых пазух 6

3.10 Компьютерная томография околоносовых пазух 7

3.11 Спирометрия с бронхолитиком 7

3.12 Электрокардиография 7

3.13 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 7

4.1 Ступенчатая терапия 7

4.2 Системные антигистаминные препараты 8
4.3 Интраназальные глюкокортикостероиды 8
4.4 Интраназальные антигистаминные и комбинированные препараты 9
4.5 Монтелукаст и кромоглициевая кислота 9
4.6 Сосудосуживающие препараты 10
4.7 Тяжёлое течение 10
4.8 Немедикаментозное лечение 10
4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия 11
4.10 Хирургическое лечение 11
4.11 Нетрадиционные методы 11
5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации 11
5.1 Возрастные ограничения 11
5.2 Беременность и лактация 11
6. Контроль лечения 12
7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12
8. Источник и актуальность 13
8.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 13

1. Основные положения

- Диагноз аллергического ринита:

  Обязательные критерии

  1. **не менее двух** из четырёх симптомов, беспокоящих ежедневно **не менее часа**: заложенность носа, ринорея, чихание, зуд в носу;
  2. связь симптомов с аллергеном;
  3. положительные результаты аллергологического обследования.
- Лечение ступенчатое:
  1. первая ступень: один препарат: антигистаминный внутрь или интраназально, кромоглициевая кислота или монтелукаст;
  2. вторая ступень: один препарат, предпочтительно интраназальный глюкокортикостероид;
  3. третья ступень: интраназальный глюкокортикостероид и один или два препарата первой ступени;
  4. четвёртая ступень: омализумаб, решение о котором принимает только специалист.
- Интраназальные глюкокортикостероиды превосходят по эффективности антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту, особенно при выраженной заложенности носа.
- Сосудосуживающие препараты допустимы только при обострении с выраженной заложенностью носа и только коротким курсом, **3–7 дней**.
- Контроль симптомов оценивают по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и **через 2–4 недели** лечения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Аллергический ринит является IgE-опосредованным воспалительным заболеванием слизистой оболочки носа, развивающимся под действием аллергенов. Для него характерны **не менее двух** симптомов, проявляющихся ежедневно **в течение часа и более**:

1. заложенность носа;
2. ринорея;
3. чихание;
4. зуд в полости носа.

2.2 Классификация

По этиологическому фактору

1. сезонный;
2. круглогодичный (бытовой);
3. профессиональный.

По течению

1. интермиттирующий: симптомы беспокоят **менее 4 дней в неделю** или **менее 4 недель в году**;
2. персистирующий: симптомы сохраняются **более 4 дней в неделю** и **более 4 недель в году**.

По тяжести

1. лёгкое течение: симптомы не нарушают сон и повседневную активность;
2. среднетяжёлое течение: симптомы препятствуют работе, учёбе, занятиям спортом и нарушают сон;
3. тяжёлое течение: без лечения пациент не может нормально работать, учиться и спать.

Кроме того, выделяют периоды обострения и ремиссии.

В формулировке диагноза указываются аллергены, к которым выявлена повышенная чувствительность.

Отдельной формой является локальный аллергический ринит. Для него характерны типичные симптомы с чёткой связью с аллергеном при отрицательных результатах кожных проб и исследования специфических IgE в крови. Определение специфических IgE в носовом секрете в России не проводится, назальные провокационные тесты положительны.

2.3 Жалобы и анамнез

Жалобы

1. заложенность носа с дыханием через рот, сопением, храпом и изменением голоса;
2. водянистые выделения из носа;
3. чихание, нередко приступообразное, чаще в утренние часы;
4. зуд, реже жжение в носу, в ряде случаев зуд нёба и глотки;
5. на поздних стадиях снижение обоняния.

Характерен «аллергический салют» (потирание кончика носа ладонью), вследствие которого формируется поперечная носовая складка.

У каждого пациента с подозрением на аллергический ринит подробно собирают жалобы и анамнез. При круглогодичной форме ведущим симптомом является заложенность носа со слизистыми выделениями, при сезонной форме преобладают приступы чихания, зуд и ринорея. Следует уточнить связь симптомов с аллергеном и наличие аллергических заболеваний у пациента и его кровных родственников.

Обильные выделения и нарушение проходимости слуховых труб могут сопровождаться раздражением и отёком кожи над верхней губой и в области крыльев носа, носовыми кровотечениями после сморкания, болью в горле и покашливанием, болью и треском в ушах при глотании, снижением слуха.

При сезонном рините часто встречается оральный аллергический синдром, представляющий собой перекрёстную непереносимость свежих фруктов, овощей, орехов и семян. Его проявления варьируют от зуда в полости рта до анафилаксии.

2.4 Физикальное обследование

Обследование всех пациентов включает осмотр верхних дыхательных путей, общий осмотр и аускультацию для выявления бронхиальной астмы, конъюнктивита и атопического дерматита.

Характерные признаки

1. затруднённое носовое дыхание, приоткрытый рот;
2. тёмные круги под глазами;
3. мацерация кожи над верхней губой;
4. отёчность лица.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Обязательные критерии

1. характерные жалобы: **не менее двух** симптомов из четырёх, ежедневно **не менее часа**;
2. данные анамнеза о связи с аллергеном или о других аллергических заболеваниях;
3. положительные результаты аллергологического обследования.

Задачи оториноларинголога

1. риноскопия и эндоскопическое исследование;
2. дифференциальная диагностика;
3. выявление осложнений и анатомических нарушений;
4. определение показаний к хирургическому лечению.

Задачи аллерголога-иммунолога

1. кожные и провокационные тесты и оценка их результатов;
2. исключение бронхиальной астмы;
3. решение вопроса об аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

3.2 Передняя риноскопия

Показания

1. все пациенты.

Диагностические признаки

1. отёк носовых раковин;
2. обильный водянистый секрет;
3. слизистая оболочка ярко-красная в период обострения сезонного ринита;
4. слизистая оболочка цианотичная или серая при круглогодичном рините, в ряде случаев пятнистая («мраморная», симптом Воячека);
5. полипы.

3.3 Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки и околоносовых пазух

Показания

1. неэффективность стандартной терапии;
2. осложнённое течение ринита.

Проба с сосудосуживающим средством позволяет оценить обратимость назальной обструкции.

3.4 Кожные пробы

Prick-тесты или скарификационные пробы при отсутствии противопоказаний.

Показания

1. подтверждение аллергической природы ринита;
2. выявление причинно-значимых аллергенов;
3. решение вопроса об АСИТ.

Пробы проводятся в аллергологическом кабинете. На результат влияют возраст младше 5 и старше 60 лет, приём системных глюкокортикоидов, антигистаминных и психотропных препаратов, дермографизм (ложноположительный результат) и недавно перенесённая острая аллергическая реакция (ложноотрицательный результат).

3.5 Специфические IgE в сыворотке крови

Показания

1. кожные пробы противопоказаны или невозможны;
2. результат кожных проб сомнителен;
3. результат кожных проб расходится с данными анамнеза.

Диагностические признаки

При использовании метода ImmunoCAP результат считается положительным при значении **более 0,70 kU/l**.

3.6 Общий IgE

Для диагностики аллергического ринита исследование общего IgE нецелесообразно, поскольку не несёт необходимой диагностической информации.

Показания

1. только перед назначением омализумаба (**с 12 лет**, при тяжёлом течении): по уровню общего IgE рассчитывают дозу препарата.

3.7 Общий (клинический) анализ крови

Показания

1. выраженные симптомы в период обострения;
2. подготовка к АСИТ.

Диагностические признаки

1. содержание эозинофилов;
2. лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево служит поводом для поиска инфекции, прежде всего острого риносинусита.

3.8 Цитологическое исследование смывов из полости носа

Показания

1. выраженные симптомы в период обострения.

Диагностические признаки

1. эозинофилия носового секрета **10% и более**.

3.9 Рентгенография околоносовых пазух

Показания

1. симптомы риносинусита: гнойные выделения, боль в проекции пазух, головная боль, повышение температуры тела;
2. лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево.

3.10 Компьютерная томография околоносовых пазух

Показания

1. неэффективность лечения;
2. выраженная и длительная назальная обструкция;
3. стойкая аносмия;
4. отрицательные результаты аллергологического обследования, прежде всего при подозрении на полипозный риносинусит.

3.11 Спирометрия с бронхолитиком

Показания

1. кашель, свистящее дыхание, одышка;
2. подготовка к АСИТ: выявление скрытого бронхоспазма.

3.12 Электрокардиография

Показания

1. подготовка к инъекционной АСИТ.

3.13 Дифференциальная диагностика

Аллергический ринит дифференцируют

1. с инфекционным ринитом;
2. с аномалиями внутриносовых структур;
3. с аденоидами у детей;
4. с полипозным риносинуситом;
5. с эозинофильным ринитом;
6. с лекарственным ринитом: на фоне приёма нестероидных противовоспалительных препаратов, альфа- и бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, резерпина, длительного применения деконгестантов;
7. с гормональным ринитом: беременность, пубертатный период, менструальный цикл, приём контрацептивов, акромегалия, гипотиреоз;
8. с профессиональным ринитом;
9. с атрофическим ринитом пожилых;
10. с пищевым и алкогольным ринитом;
11. с идиопатическим ринитом;
12. с первичной цилиарной дискинезией и муковисцидозом.

---

4. Лечение

Целью лечения является полный контроль симптомов. При продолжающемся контакте с аллергеном, табачным дымом или другими раздражителями достижимо лишь уменьшение выраженности симптомов.

4.1 Ступенчатая терапия

На любой ступени:

1. исключение контакта с аллергеном;
2. хирургическое лечение сопутствующей патологии при наличии показаний;
3. рассмотрение вопроса об АСИТ.

1. Первая ступень. Один препарат: антигистаминный препарат без седативного эффекта внутрь, антигистаминный препарат интраназально, кромоглициевая кислота интраназально или монтелукаст.
2. Вторая ступень. Один препарат, предпочтительно интраназальный глюкокортикостероид; возможно назначение антигистаминного препарата внутрь или интраназально либо монтелукаста.
3. Третья ступень. Интраназальный глюкокортикостероид в сочетании с одним или несколькими препаратами: антигистаминным препаратом внутрь или интраназально, монтелукастом.
4. Четвёртая ступень. Омализумаб при тяжёлом течении, **с 12 лет**. Назначается только специалистом.

Препараты скорой помощи на любой ступени: сосудосуживающие препараты коротким курсом или глюкокортикоиды внутрь.

> Перед переходом на ступень выше следует повторно оценить правильность диагноза, приверженность лечению, наличие сопутствующих заболеваний и анатомических аномалий.

4.2 Системные антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты без седативного эффекта рекомендованы всем пациентам: они уменьшают зуд, чихание, ринорею и заложенность носа. Цетиризин в высоких дозах чаще других препаратов вызывает сонливость.

Назначение седативных антигистаминных препаратов первого поколения не рекомендуется, поскольку они вызывают сонливость, нарушают сон и могут приводить к развитию апноэ во сне.

Препарат	Доза
Дезлоратадин	Взрослым и детям с 12 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 2,5 мг, детям 1–5 лет — 1,25 мг, детям 6–12 месяцев — 1 мг 1 раз в сутки.
Левоцетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5 мг 1 раз в сутки, детям 2–6 лет — 1,25 мг 2 раза в сутки.
Лоратадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–12 лет при массе тела до 30 кг — 5 мг, более 30 кг — 10 мг 1 раз в сутки.
Фексофенадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 120 мг 1 раз в сутки, детям 6–11 лет — 30 мг 2 раза в сутки.
Цетиризин	Взрослым и детям старше 6 лет — 5–10 мг 1 раз в сутки. Детям 2–6 лет — 2,5 мг 2 раза или 5 мг 1 раз в сутки, детям 1–2 лет — 2,5 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 месяцев — 2,5 мг 1 раз в сутки.
Эбастин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10–20 мг 1 раз в сутки. Имеется лекарственная форма для рассасывания под языком.
Рупатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 10 мг 1 раз в сутки.
Биластин	Взрослым и детям старше 12 лет — 20 мг 1 раз в сутки.

4.3 Интраназальные глюкокортикостероиды

Интраназальные глюкокортикостероиды показаны при среднетяжёлом и тяжёлом течении, особенно при выраженной заложенности носа. По эффективности они превосходят антигистаминные препараты для приёма внутрь и кромоглициевую кислоту и уменьшают также глазные симптомы. Возможны сухость слизистой оболочки, носовые кровотечения, редко перфорация носовой перегородки, поэтому пациента следует обучить правильной технике введения спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Мометазон	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза; при необходимости до 4 доз. Детям 2–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Флутиказона фуроат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (55 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза. Детям 2–12 лет — 1 доза (27,5 мкг) 1 раз в сутки, при необходимости 2 дозы.
Флутиказона пропионат	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы (100 мкг) 1 раз в сутки, для поддерживающей терапии — 1 доза. Детям 4–12 лет — 1 доза (50 мкг) 1 раз в сутки.
Будесонид	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки, для поддерживающей терапии — 200 мкг в сутки. Не более 3 месяцев.
Беклометазон	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы (100 мкг) 2 раза в сутки (максимальная доза); для поддерживающей терапии — 1 доза 2 раза в сутки.

4.4 Интраназальные антигистаминные и комбинированные препараты

Интраназальные антигистаминные препараты быстро, в течение 30 минут, уменьшают выраженность симптомов. Их применяют в монотерапии или в сочетании с другими препаратами; возможна сухость слизистой оболочки носа.

При необходимости одновременного интраназального применения антигистаминного препарата и глюкокортикостероида целесообразно назначение одного комбинированного спрея.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Азеластин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза (0,14 мг) 2 раза в сутки, с 12 лет при необходимости 2 дозы. Не более 6 месяцев.
Левокабастин	Взрослым и детям старше 6 лет — 2 дозы 2 раза в сутки, при выраженных симптомах 3–4 раза. При отсутствии эффекта в течение 3 дней препарат отменяется.
Азеластин и флутиказон	Взрослым и детям старше 12 лет — 1 доза (137 мкг азеластина и 50 мкг флутиказона) 2 раза в сутки.
Азеластин и мометазон	Взрослым с 18 лет — 1 доза (140 мкг азеластина и 50 мкг мометазона) 2 раза в сутки, курс 2 недели.
Мометазон и олопатадин	Взрослым и детям старше 12 лет — 2 дозы 2 раза в сутки (в КР указано 50 мкг мометазона и 1200 мкг олопатадина). Детям 6–11 лет только при сезонном рините — 1 доза (25 и 600 мкг) 2 раза в сутки.

4.5 Монелукаст и кромоглициевая кислота

Монелукаст может назначаться при любой степени тяжести, в монотерапии или в сочетании с другими препаратами, однако по эффективности он уступает интраназальным глюкокортикостероидам.

При сопутствующей бронхиальной астме монелукаст позволяет контролировать оба заболевания. Курс лечения составляет от 1 до 3 месяцев и более; согласно инструкции, ограничений по длительности применения нет.

При необходимости назначения и антигистаминного препарата внутрь, и монелукаста возможно применение комбинированной таблетки левоцетиризина с монелукастом.

Кромоглициевую кислоту интраназально используют при лёгком течении. Препарат безопасен, однако по эффективности уступает антигистаминным препаратам, монелукасту и интраназальным глюкокортикостероидам.

Препарат	Доза
Монтелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 10 мг 1 раз в сутки, детям 6–15 лет — 5 мг, детям 2–6 лет — 4 мг (жевательная таблетка) 1 раз в сутки.
Левоцетиризин и монтелукаст	Взрослым и детям старше 15 лет — 1 таблетка (5 мг и 10 мг) 1 раз в сутки.
Кромоглициевая кислота, спрей	Взрослым и детям старше 5 лет — 1 доза в каждый носовой ход 4 раза в сутки, при необходимости до 6 раз. После достижения эффекта возможно применение только при контакте с аллергеном. Курс 4 недели.

4.6 Сосудосуживающие препараты

При обострении с выраженной заложенностью носа сосудосуживающие препараты применяют коротким курсом, **3–7 дней**.

Длительное применение не рекомендуется: **после 10 дней** развиваются привыкание, отёк слизистой оболочки и медикаментозный ринит.

При необходимости интраназального применения и антигистаминного, и сосудосуживающего препарата возможно назначение комбинации диметиндена с фенилэфрином, не более 7 дней.

Препарат	Доза в каждый носовой ход
Оксиметазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы 0,05% раствора 2–3 раза в сутки. Детям 1–6 лет — 1–2 капли 0,025%, детям от 5 недель до года — 1–2 капли 0,01%, до 4 недель — 1 капля 0,01% 2–3 раза в сутки. Курс 3–4 дня.
Ксилометазолин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1 доза 0,1% раствора 1–3 раза в сутки, детям 2–6 лет — 1 доза 0,05% 1–2 раза в сутки. Не более 5–7 дней.
Диметинден и фенилэфрин	Взрослым и детям старше 6 лет — 1–2 дозы спрея или 3–4 капли 3–4 раза в сутки. Детям 1–6 лет — только капли, по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

4.7 Тяжёлое течение

При тяжёлом обострении или неэффективности третьей ступени возможно назначение короткого курса глюкокортикоидов внутрь.

Системные глюкокортикоиды являются терапией четвёртой линии или средством лечения тяжёлого обострения. Введение растворов и депо-форм глюкокортикоидов в носовые раковины недопустимо, поскольку сопряжено с риском тяжёлых осложнений вплоть до слепоты. Доза преднизолона, метилпреднизолона или дексаметазона подбирается индивидуально; преднизолон в таблетках противопоказан детям до 3 лет.

Назначение депо-форм глюкокортикоидов не рекомендуется в связи с быстрым развитием побочных эффектов, вплоть до надпочечниковой недостаточности.

Назначение омализумаба рассматривается с 12 лет при тяжёлом персистирующем течении или тяжёлом обострении в случае неэффективности третьей ступени.

Препарат вводится подкожно каждые 2 или 4 недели в дозе от 75 до 600 мг в соответствии с таблицей дозирования. При сезонном рините введение начинается не менее чем за неделю до начала пыления и продолжается до его окончания.

4.8 Немедикаментозное лечение

Всем пациентам рекомендуется по возможности избегать контакта с аллергеном. Даже частичное ограничение контакта облегчает течение заболевания и снижает потребность в лекарственных препаратах.

Рекомендуется применение изотонических солевых растворов для носа, в том числе на основе морской воды.

Перед введением интраназального глюкокортикостероида полость носа целесообразно промыть: это улучшает контакт препарата со слизистой оболочкой и снижает частоту сухости и носовых кровотечений.

4.9 Аллерген-специфическая иммунотерапия

Проведение АСИТ рассматривается у всех пациентов в период ремиссии, в том числе медикаментозной. Метод уменьшает выраженность симптомов и потребность в лекарственных препаратах, предупреждает развитие бронхиальной астмы и расширение спектра аллергенов.

Показания, противопоказания и выбор аллергена определяются аллергологом-иммунологом, которым и назначается АСИТ.

4.10 Хирургическое лечение

К хирургическому лечению прибегают только при сопутствующей патологии; показания определяются оториноларингологом по данным эндоскопического и рентгенологического исследования. Плановые операции в сезон пыления причинно-значимых аллергенов не выполняют.

4.11 Нетрадиционные методы

Гомеопатия, фитотерапия, гипноз, техники релаксации, ионизаторы воздуха и физиотерапия не рекомендуются в связи с отсутствием доказательств их эффективности.

Иглоукалывание может рассматриваться в составе комплексной терапии.

---

5. Особенности лечения у детей, при беременности и лактации

5.1 Возрастные ограничения

Мометазон и флутиказона фуроат разрешены к применению с 2 лет, флутиказона пропионат с 4 лет, беклометазон и будесонид с 6 лет.

Цетиризин и дезлоратадин разрешены с 6 месяцев, лоратадин с 2 лет. Антигистаминные препараты первого поколения (хлоропирамин, диметинден) разрешены с 1 месяца, однако по достижении ребёнком соответствующего возраста предпочтение отдаётся препаратам без седативного эффекта.

Монтелукаст в дозе 4 мг разрешён с 2 лет, в дозе 5 мг с 6 лет.

Согласно инструкциям к препаратам, АСИТ возможна с 5 лет.

Детям интраназальные глюкокортикостероиды применяют в минимальной эффективной дозе; при длительном применении необходим контроль роста.

Предпочтительно ограничить применение препаратов с высокой биодоступностью: будесонида (30–40%) и беклометазона (40–50%). Биодоступность дексаметазона превышает 80%, что следует учитывать, поскольку он входит в состав многих комбинированных капель.

5.2 Беременность и лактация

У беременных необходимо учитывать возможность ринита беременных, который характеризуется заложенностью носа без признаков инфекции и аллергии и полностью регрессирует в течение 2 недель после родов. Выявленная сенсибилизация свидетельствует в пользу аллергического ринита.

Кожные пробы во время беременности и лактации не выполняют; для аллергологического обследования исследуется уровень специфических IgE в сыворотке крови.

Предпочтение отдаётся элиминационным мероприятиям и промыванию полости носа. К лекарственной терапии переходят при их недостаточной эффективности с учётом рисков для матери и ребёнка.

Для лоратадина, цетиризина и будесонида доказательства риска для человека отсутствуют (категория B по классификации Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, FDA).

В первом триместре назначения лекарственных препаратов по возможности следует избегать, за исключением случаев жизненной необходимости.

В период лактации предпочтительно ограничиться местными средствами с минимальной биодоступностью, поскольку все системные препараты проникают в грудное молоко.

---

6. Контроль лечения

Контроль симптомов оценивается по визуальной аналоговой шкале и тесту «дыхание с закрытым ртом» при первичном обращении и через 2–4 недели лечения. Методика оценки приведена ниже.

Визуальная аналоговая шкала представляет собой линию длиной 10 см, на которой пациент отмечает выраженность беспокоящих его симптомов. При отметке от 0 до 50 мм ринит считается контролируемым, при отметке 50 мм и более неконтролируемым.

У подростков и взрослых при отметке 5 см и более лечение начинается с антигистаминных препаратов на 2–4 недели. При достижении контроля лечение продолжается по потребности и рассматривается вопрос об АСИТ. При отсутствии контроля добавляется интраназальный глюкокортикостероид или монтелукаст ещё на 2–4 недели. Если контроль не достигнут и в этом случае, следует пересмотреть диагноз, провести поиск сопутствующей патологии, рассмотреть АСИТ и хирургическое лечение.

Ринит считается контролируемым, если за последние 4 недели симптомы отсутствовали, не нарушались сон и дневная активность, а результат теста «дыхание с закрытым ртом» нормальный. Любое отклонение, в том числе учащение потребности в препаратах скорой помощи, свидетельствует о потере контроля; в этом случае возможен переход на ступень выше.

Для проведения теста пациенту предлагается закрыть рот и в течение 30 секунд дышать только носом.

При ведении дневника симптомов (шкала TNSS, суммарная оценка назальных симптомов) пациент ежедневно оценивает чихание, водянистые выделения, заложенность и зуд от 0 до 3 баллов; суммарный балл составляет от 0 до 12. Врач рассчитывает среднее значение за 7 дней. Дневник ведётся в период обострения и для оценки эффективности АСИТ.

Отдельно оценивается медикаментозная нагрузка: приём только антигистаминных препаратов соответствует 1 баллу, интраназальных глюкокортикостероидов 2 баллам, системных глюкокортикоидов 3 баллам.

---

7. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

Каждому пациенту или его представителям следует разъяснить суть заболевания, составить индивидуальный план лечения и обучить навыкам самостоятельного контроля заболевания.

Пациенты подлежат диспансерному наблюдению у аллерголога-иммунолога или оториноларинголога: взрослые **не реже одного раза в год**, дети **не реже двух раз в год**. Наблюдение осуществляется пожизненно или до достижения стойкой ремиссии длительностью **3 года и более**.

АСИТ применяется и для вторичной профилактики: она позволяет предупредить развитие бронхиальной астмы, утяжеление течения ринита и расширение спектра сенсибилизации.

При пыльцевой сенсибилизации рекомендуется ограничить употребление перекрёстно реагирующих продуктов и растительных лекарственных средств.

Лечение, как правило, амбулаторное.

Показания к госпитализации

1. крайне тяжёлое или осложнённое течение;
2. у детей тяжёлое обострение с выраженной заложенностью носа;
3. плановое проведение ускоренного курса АСИТ.

Критерии выписки

1. достижение контроля над симптомами;
2. завершение курса АСИТ.

8. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Аллергический ринит»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 11.07.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2027 года
Код в рубрикаторе	261_2 · открыть текст КР ↗
Разработчики	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

8.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Разовая доза кромоглициевой кислоты указана в КР как «2.8 мкг», суточная как «22.4 мкг»; эти значения следует сверить с инструкцией в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
- Подпись к алгоритму в приложении Г1 гласит «пациентов, получавших лечение ранее», тогда как в оригинальном названии указано «untreated patients», то есть пациенты, не получавшие лечения.